

Mujer de 28 años con dolor pélvico y falta de regla

Caso clínico de Obstetricia · Nivel: estudiante de grado · Código: OB-04

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Elena V. C.
Edad	28 años
Profesión	Camarera
Estado civil	Soltera
Fórmula obstétrica	G2 P1 A0
Edad gestacional	Amenorrea de 7 semanas (gestación no confirmada por ecografía aún)

Motivo de consulta

Dolor en la parte baja del abdomen, sobre todo en el lado derecho, y un pequeño sangrado vaginal.

Antecedentes

Personales	Enfermedad inflamatoria pélvica hace 3 años. Portadora de DIU de cobre.
Familiares	Sin interés.
Gineco-obstétricos	Un parto previo. Ciclos regulares. Última regla hace 7 semanas, más escasa de lo habitual.
Hábitos	Fuma 10 cigarrillos/día.

Historia de la enfermedad actual

Dolor en fosa iliaca derecha de 2 días, cólico, en aumento, que ahora es continuo. Sangrado vaginal escaso y oscuro ("manchado") desde ayer, distinto a su regla. Refiere náuseas y, en las últimas horas, dolor referido al hombro derecho al tumbarse. Sensación de mareo. Niega fiebre. Recuerda que se le ha retrasado la regla.

Exploración física

TA 100/62 mmHg, FC 104 lpm, Tª 36,8 °C, palidez cutánea. Abdomen doloroso en fosa iliaca derecha con defensa localizada y dolor a la descompresión. Especuloscopia: escaso sangrado por orificio cervical externo, hilos de DIU visibles. Tacto bimanual: dolor a la movilización cervical y masa anexial derecha dolorosa. Útero de tamaño menor al esperado por amenorrea.

Pruebas complementarias disponibles

- Test de embarazo en orina: positivo.
- Beta-hCG sérica: 2.100 mUI/mL.
- Ecografía transvaginal: útero vacío (sin saco gestacional intraútero), línea endometrial engrosada, imagen anexial derecha heterogénea de 3 cm junto al ovario y líquido libre en Douglas.

- Hemograma: Hb 10,8 g/dL. Grupo sanguíneo: 0 Rh negativo.
- Repetición de beta-hCG a 48 h: ascenso subóptimo (no se duplica).

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Elena, 28 años. Tienes dolor en el lado derecho del bajo vientre que va a más y un manchado oscuro. Estás preocupada y un poco mareada. Hablas con naturalidad. Si te preguntan, cuentas que llevas el DIU de cobre, que tuviste una infección pélvica hace años y que fumas. Mencionas que se te ha retrasado la regla. Si te preguntan por el hombro, dices que sí, que te ha empezado a doler el hombro derecho al tumbarte y no entiendes por qué. No sabes términos médicos.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Embarazo ectópico (probablemente tubárico derecho): test de embarazo positivo, útero vacío en ecografía con beta-hCG de 2.100 (por encima de la zona discriminatoria), masa anexial y líquido libre. Signos de posible sangrado intraabdominal (dolor en hombro, taquicardia, anemia).

Diagnóstico diferencial

- Aborto en curso / amenaza de aborto
- Gestación intrauterina precoz no visible
- Quiste ovárico complicado / torsión
- Apendicitis aguda
- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Cuerpo lúteo hemorrágico

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Amenorrea + dolor + sangrado: tríada clásica del ectópico.
- Factores de riesgo: EIP previa, DIU, tabaco, cirugía tubárica.
- Signos de irritación peritoneal y dolor escapular (hemoperitoneo).
- Valorar estabilidad hemodinámica.

Pruebas que debería solicitar

- Test de embarazo / beta-hCG cuantitativa (y repetir a 48 h).
- Ecografía transvaginal (útero vacío + masa anexial + líquido libre).
- Hemograma, grupo y Rh (gestión de isoimmunización y posible transfusión).
- Pruebas cruzadas si inestabilidad.

Manejo / tratamiento correcto

Confirmar el diagnóstico (beta-hCG + ecografía). Si inestabilidad hemodinámica o signos de rotura: cirugía urgente (laparoscopia, generalmente salpinguectomía). Si estable y criterios adecuados (beta-hCG no muy alta, ectópico pequeño, sin latido): metotrexato. Administrar gammaglobulina anti-D por ser Rh negativa. Retirar/valorar el DIU. Reanimación con sueros y reserva de sangre si precisa.

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Reconoce la tríada amenorrea + dolor + sangrado y pide test de embarazo	20
Identifica factores de riesgo (EIP, DIU, tabaco)	10
Interpreta beta-hCG con útero vacío y solicita ecografía transvaginal	20
Diagnostica embarazo ectópico	20
Valora estabilidad y decide cirugía vs metotrexato adecuadamente	20
Indica gammaglobulina anti-D por ser Rh negativa	10
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- Asumir aborto y enviar a casa sin ecografía.
- No solicitar beta-hCG cuantitativa ni ecografía transvaginal.
- No reconocer signos de hemoperitoneo (dolor en hombro, hipotensión).
- Olvidar la profilaxis anti-D en paciente Rh negativa.